Fisura anal crónica: ¿sucralfato tópico mejor que nitroglicerina?

Lohsiriwat V, Gosoom N, Ovartchaiyapong P. 3% sucralfate-containing topical formulation versus 0.2% topical nitroglycerin for chronic anal fissure: a double-blind randomized controlled trial. *Am J Gastroenterol*. 2026 (publicado antes de impresión).
doi:10.14309/ajg.0000000000004248
Versión 1.0 · Revisado el 7 de noviembre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?
Todavía no
Señal prometedora de un tratamiento con otro mecanismo, pero es un solo ensayo pequeño, con un producto comercial de varios componentes y un comparador dado por poco tiempo.

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?
Bien hecho, pero pequeño
Aleatorización y ocultamiento correctos, evaluador cegado y sin pérdidas en el desenlace primario. Con 82 pacientes, el IC es amplio y bastaban 3–4 resultados distintos para perder la significancia.

CUIDADO AL INTERPRETAR
¿Contra qué y qué se probó?
Nitroglicerina al 0.2 % (concentración estándar), pero solo por 4 semanas y sin ningún caso de cefalea. El brazo activo no es "sucralfato" solo: es una pomada con manteca de cacao, lanolina, caléndula, manzanilla y hamamelis.

En 30 segundos. Ensayo doble ciego de un centro en Tailandia: 82 adultos con fisura anal crónica primaria recibieron, dos veces al día por 4 semanas, una pomada comercial con **sucralfato al 3 %** (n = 42) o **nitroglicerina al 0.2 %** de farmacia hospitalaria (n = 40), más fibra, baños de asiento y laxantes según necesidad. La curación completa a las 2 semanas (desenlace primario) fue del **50 % vs. 23 %** (RR 2.22; IC 95 % 1.16–4.26) y a las 4 semanas del **79 % vs. 48 %** (RR 1.65; IC 95 % 1.15–2.38), con un NNT de 4. El **dolor y la calidad de vida mejoraron sin diferencia significativa** entre grupos. Las recurrencias fueron similares (19 % vs. 24 %), con una mediana de seguimiento de 19 meses.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN
El comparador activo: cuando un ensayo dice "mejor que el estándar", hay que revisar si el estándar se dio a la dosis y por el tiempo habituales. Además: intervenciones con varios componentes, cálculo de muestra con supuestos optimistas y el índice de fragilidad.

1 La pregunta clínica (PICO)

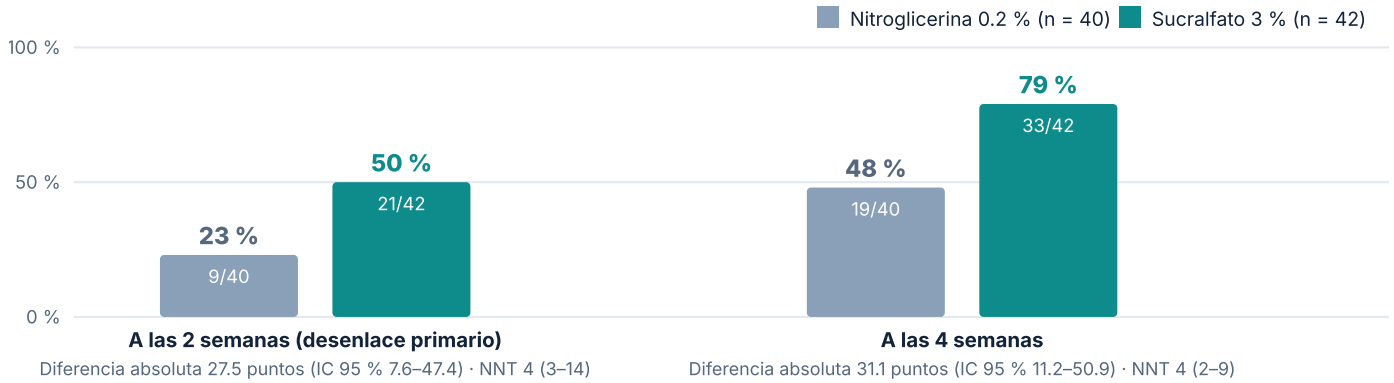
P · POBLACIÓN	82 adultos con fisura anal crónica primaria (síntomas >4 semanas más signos de cronicidad: bordes indurados, esfínter interno expuesto, pliegue centinela o papila hipertrófica). Mediana: 46 años y 8 semanas de síntomas; 45 % hombres. Se excluyeron fisuras secundarias, inmunocompromiso, embarazo y lactancia.
I · INTERVENCIÓN	Pomada rectal comercial con sucralfato al 3 % más emolientes y extractos vegetales, del tamaño de un chícharo, dos veces al día hasta 4 semanas.
C · COMPARADOR	Nitroglicerina al 0.2 % preparada en la farmacia del hospital, mismo esquema. Ambos grupos: fibra, baños de asiento tibios, laxantes según necesidad y analgésicos permitidos.
O · DESENLACES	Primario: curación completa (epitelización total) a las 2 semanas, evaluada por un cirujano colorrectal cegado. Secundarios: curación a las 4 semanas, dolor (escala 0–10), calidad de vida (HEMO-FISS-QoL), eventos adversos y recurrencia.

2 Diseño

TIPO	Ensayo de superioridad, paralelo, doble ciego, 1:1, en un centro (mayo de 2024 a diciembre de 2025). Registrado antes de iniciar (TCTR20240525002).
ALEATORIZACIÓN	Secuencia por computadora en bloques de 4, generada por un estadístico independiente; sobres opacos, sellados y numerados. Medicamentos en envases idénticos codificados por un farmacéutico independiente.
MUESTRA	Calculada asumiendo una curación del 82 % con sucralfato (de una serie de casos) vs. 49 % con nitratos: 78 pacientes con 90 % de poder. Meta registrada: 92. Se cerró en 82 porque se agotó el suministro del producto; en ese momento todos ya tenían evaluado el desenlace primario.
ANÁLISIS	Por intención de tratar. Sin pérdidas ni cruces en los desenlaces primario y secundarios a corto plazo; adherencia >80 % en todos (autorreporte). Sin financiamiento externo ni conflictos declarados.

3 Resultados

Curación completa de la fisura (epitelización total, evaluador cegado)



Diferencia absoluta 27.5 puntos (IC 95 % 7.6–47.4) · NNT 4 (3–14)

Diferencia absoluta 31.1 puntos (IC 95 % 11.2–50.9) · NNT 4 (2–9)

Dolor y calidad de vida al final: sin diferencia (OR común ajustado 0.58; IC 95 % 0.25–1.33 · diferencia de medias −3; IC 95 % −8 a 2).

Elaborado por Medicina en Resumen con los datos de la tabla 2 del artículo. No reproduce figuras originales.

DESENLACE	NITROGLICERINA (N = 40)	SUCRALFATO (N = 42)	EFECTO (IC 95 %)
Curación a 2 semanas (primario)	9 (23 %)	21 (50 %)	**RR 2.22 (1.16–4.26)**
Curación a 4 semanas	19 (48 %)	33 (79 %)	**RR 1.65 (1.15–2.38)**
Dolor al final, mediana (RIC)	2 (0–3)	0 (0–4)	OR común ajustado 0.58 (0.25–1.33)
Calidad de vida al final, mediana (RIC)	11 (3–20)	7 (2–21)	Dif. ajustada −3 (−8 a 2)
Cefalea	0	0	—
Prurito / ardor perianal	5 (13 %) / 6 (15 %)	4 (10 %) / 4 (10 %)	p = 0.735 / 0.514
Recurrencia en curados con seguimiento	4/17 (24 %)	5/27 (19 %)	p = 0.716

Ningún evento adverso obligó a suspender el tratamiento; el uso de analgésicos, fibra y laxantes fue similar. De 52 curados, 44 (85 %) tuvieron seguimiento a largo plazo.

4 Cómo leer estos resultados

- **El comparador.** DATO DEL ARTÍCULO Se usó nitroglicerina al 0.2 % por 4 semanas. Los autores señalan que algunos estudios usan la presentación al 0.4 % y que la ausencia de cefalea (0 de 40) podría reflejar menor exposición sistémica o polimorfismos genéticos de ALDH2 (no medidos). INTERPRETACIÓN El 0.2 % es una concentración estándar, pero 4 semanas es menos que los esquemas habituales, y cero cefaleas sugiere poca exposición. Su curación a 4 semanas (48 %) quedó en el límite inferior del rango publicado (49–58 %), que suele corresponder a tratamientos más largos. El ensayo tampoco comparó contra diltiazem tópico, la otra opción habitual de primera línea.
- **¿Sucralfato o la pomada?** DATO DEL ARTÍCULO El producto contiene sucralfato y varios emolientes y extractos vegetales; los autores reconocen que no se puede saber qué aporta cada uno. INTERPRETACIÓN El resultado aplica a esa formulación comercial, no a "sucralfato" en general. No hubo grupo con pomada base sin sucralfato.

- **Curar no fue lo mismo que doler menos.** DATO DEL ARTÍCULO Más fisuras cerradas con sucralfato, pero sin diferencia en dolor ni en calidad de vida. INTERPRETACIÓN Que la ventaja en epitelización no se tradujera en menos dolor obliga a ser prudente; los autores lo atribuyen a que la nitroglicerina relaja el esfínter aunque la fisura no cierre.
- **Un efecto grande en un ensayo pequeño.** DATO DEL ARTÍCULO La diferencia absoluta a las 2 semanas fue de 27.5 puntos, con un IC de 7.6 a 47.4; el NNT de 4 tiene un IC de 3 a 14. INTERPRETACIÓN El efecto real podría ser desde modesto hasta enorme. Con cálculo propio (prueba exacta de Fisher), bastaba que 3 pacientes curados con sucralfato no hubieran curado a las 2 semanas, o 4 a las 4 semanas, para perder la significancia estadística.
- **Un desenlace primario temprano.** DATO DEL ARTÍCULO El primario fue a las 2 semanas, con tratamiento de solo 4. INTERPRETACIÓN Muchos esquemas con nitratos se dan por 6–8 semanas; un desenlace tan temprano favorece a un tratamiento que cierre rápido, pero no dice cuál cura más a largo plazo.

CONCEPTO CLAVE · EL COMPARADOR Y EL ÍNDICE DE FRAGILIDAD

Comparador activo: un ensayo de superioridad contra otro tratamiento solo es tan informativo como lo justo que sea ese comparador. Revisa dosis, duración y si es el que usarías en la práctica. Un comparador dado por poco tiempo o a dosis baja hace que cualquier alternativa parezca mejor. **Cálculo de muestra optimista:** aquí se esperaba un 82 % de curación con sucralfato, tomado de una serie de casos; cuando el efecto supuesto es grande, la muestra resulta pequeña y el IC queda amplio. **Índice de fragilidad:** el número de pacientes que tendrían que cambiar de resultado para que p deje de ser <0.05. Ayuda a dimensionar ensayos pequeños, sin reemplazar el IC.

5 Validez, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
● Aleatorización y ocultamiento	Secuencia independiente, sobres opacos y envases idénticos codificados.	Confirmado
● Evaluador cegado y sin pérdidas	El mismo cirujano cegado evaluó a cada paciente; 100 % con desenlace primario.	Confirmado
● Cegamiento del paciente	La consistencia y el olor de las pomadas eran distintos, lo que pudo afectar el dolor y la calidad de vida reportados.	Reconocido por los autores
● Comparador por poco tiempo	Nitroglicerina al 0.2 % (estándar), pero solo 4 semanas y sin cefalea en ningún paciente.	Reconocido parcialmente
● Intervención con varios componentes	Un producto comercial; no se puede atribuir el efecto al sucralfato.	Reconocido por los autores
● Un centro, muestra pequeña	82 pacientes (meta 92); sin manometría; solo fisuras primarias; la aplicación no se midió objetivamente.	Reconocido parcialmente

Pregunta de repaso: un paciente con fisura anal posterior crónica te pregunta si le conviene la pomada de sucralfato "porque cura el doble que la nitroglicerina". ¿Qué le respondes?
Respuesta. Que en un ensayo pequeño de un centro curó más fisuras que la nitroglicerina al 0.2 % (el doble a las 2 semanas, pero 1.65 veces a las 4),[1] sin disminuir más el dolor; además, la nitroglicerina se dio por menos tiempo del habitual y el producto contiene otros componentes además del sucralfato. Hoy sigue siendo razonable el manejo habitual: fibra, ablandar las evacuaciones, baños de asiento y un tratamiento tópico de primera línea (nitratos o diltiazem). El sucralfato es una opción a vigilar hasta que se confirme en ensayos más grandes.

¿Qué aprendí de medicina?

- La fisura crónica es un problema de esfínter y también de herida que no cierra.
- Sucralfato tópico: se propone que actúa sobre la herida, no sobre el esfínter (no medido).
- En este ensayo, más curación sin menos dolor.

¿Qué aprendí de investigación?

- Revisa la dosis y la duración del comparador activo.
- Una pomada con varios ingredientes ≠ el fármaco solo.
- Supuestos de muestra optimistas → IC amplios.

6 Referencias

1. Lohsiriwat V, Gosoom N, Ovartchaiyapong P. 3% sucralfate-containing topical formulation versus 0.2% topical nitroglycerin for chronic anal fissure: a double-blind randomized controlled trial. Am J Gastroenterol. 2026. doi:10.14309/ajg.0000000000004248

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. DATO DEL ARTÍCULO = lo que reportan los autores; INTERPRETACIÓN = lectura editorial de Medicina en Resumen. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante.